Model Report

Dokumentacja

Version 1.0 ●

Date/Time Generated:	15.03.2026 20:32:31
Author:	Mateusz Janiszewski

EA Repository : C:\Users\Mateusz\EAP\MPSI.EAP

CREATED WITH ENTERPRISE ARCHITECT

Table of Contents

Dokumentacja 5
dokumentacja diagram 5
Przedstawienie problemu - dokument Zamawiającego 5
1.1.1 Przedstawienie problemu - dokument zamawiającego 6
Przedstawienie problemu dla systemu dyplom 6
1. Cel działalności firmy 6
2. Opis firmy 6
3. Aktorzy 7
3.1 Pacjent (Klient) 7
3.2 Recepcjonista 7
3.3 Lekarz 7
3.4 Administrator 7
3.5 Kierownictwo kliniki / właściciel 7
4. Procesy 7
4.1 Rezerwacja wizyty: 7
4.2 Zmiana / odwołanie wizyty: 7
4.3 Zarządzanie grafikiem lekarzy: 7
4.4 Rejestracja pacjenta: 7
4.5 Raportowanie: 7
5. Ograniczenia 7
5.1 Termin zakończenia projektu 7
5.2 Bezpieczeństwo danych osobowych 8
5.3 Organizacyjne 8
5.3 Techniczne 8
Wizja projektu systemu dyplom 8
1.1 Wstęp 11
1.1.1 Cel 11
1.1.2 Zakres 11
1.1.3 Definicje, akronimy, skróty 11
1.1.4 Dokumenty powiązane 11
1.1.5 Organizacja dokumentu 11
1.2 Założenia projektu (Positioning) 12
1.2.1 Cele biznesowe 12
1.2.2 Opis problemu/potrzeby 12
1.2.3 Product Position Statement (jak to przetłumaczyć). Nie wiem czy tego kawałka nie wywalić 13
1.3 Udziałowcy i użytkownicy 13
1.3.1 Udziałowcy 13
1.3.2 Użytkownicy 14
1.3.3 Środowisko użytkownika 14
1.3.4 Profile udziałowców 15
1.3.4.1 <Nazwa udziałowca> 15
1.3.5 Profile użytkowników 16
1.3.5.1 <Nazwa użytkownika> 16
1.3.6 Główni uczestnicy lub potrzeby klienta 17
1.3.7 Alternatywy i konkurencja 18
1.4 Ograniczenia 18
1.5 Wymagania jakości 18
1.6 Priorytety 18
1.7 Pozostałe wymagania 18

1.7.1 Stosowane standardy 18
1.7.2 Wymagania systemowe i sprzętowe 18
1.7.3 Wymagania wydajnościowe 19
1.7.4 Wymagania związane ze środowiskiem pracy 19
Analiza lingwistyczna 19
1.1 Analiza lingwistyczna 19
1.1 Treść 19
1.2 Analiza grup czasownikowych 19
2. Słownik systemu 20
Raport konfiguracji oprogramowania 21
1.2 Raport konfiguracji oprogramowania 21
Dokumenty etapu definicji 21
Przedstawienie problemu - dokument Zamawiającego 21
Przedstawienie problemu - dokument Zamawiającego 22
1.1.1.1.1 Przedstawienie problemu - dokument zamawiającego 22
Przedstawienie problemu dla systemu dyplom 23
Przedstawienie problemu dla systemu dyplom 23
1. Cel działalności firmy 23
2. Opis firmy 23
3. Aktorzy 23
3.1 Pacjent (Klient) 23
3.2 Recepcjonista 23
3.3 Lekarz 23
3.4 Administrator 23
3.5 Kierownictwo kliniki / właściciel 23
4. Procesy 24
4.1 Rezerwacja wizyty: 24
4.2 Zmiana / odwołanie wizyty: 24
4.3 Zarządzanie grafikiem lekarzy: 24
4.4 Rejestracja pacjenta: 24
4.5 Raportowanie: 24
5. Ograniczenia 24
5.1 Termin zakończenia projektu 24
5.2 Bezpieczeństwo danych osobowych 24
5.3 Organizacyjne 24
5.3 Techniczne 24
Wizja projektu systemu dyplom 25
Wizja projektu systemu dyplom 25
1.7.4.1 Wstęp 28
1.7.4.1.1 Cel 28
1.7.4.1.2 Zakres 28
1.7.4.1.3 Definicje, akronimy, skróty 28
1.7.4.1.4 Dokumenty powiązane 28
1.7.4.1.5 Organizacja dokumentu 28
1.7.4.2 Założenia projektu (Positioning) 28
1.7.4.2.1 Cele biznesowe 29
1.7.4.2.2 Opis problemu/potrzeby 29
1.7.4.2.3 Product Position Statement (jak to przetłumaczyć). Nie wiem czy tego kawałka nie wywalić 29
1.7.4.3 Udziałowcy i użytkownicy 30
1.7.4.3.1 Udziałowcy 30
1.7.4.3.2 Użytkownicy 30
1.7.4.3.3 Środowisko użytkownika 31
1.7.4.3.4 Profile udziałowców 31

1.7.4.3.4.1 <Nazwa udziałowca> *31*
1.7.4.3.5 Profile użytkowników 32
1.7.4.3.5.1 <Nazwa użytkownika> *32*
1.7.4.3.6 Główni uczestnicy lub potrzeby klienta 34
1.7.4.3.7 Alternatywy i konkurencja 34
1.7.4.4 Ograniczenia *34*
1.7.4.5 Wymagania jakości *34*
1.7.4.6 Priorytety *35*
1.7.4.7 Pozostałe wymagania *35*
1.7.4.7.1 Stosowane standardy 35
1.7.4.7.2 Wymagania systemowe i sprzętowe 35
1.7.4.7.3 Wymagania wydajnościowe 35
1.7.4.7.4 Wymagania związane ze środowiskiem pracy 35
Analiza lingwistyczna 36
Analiza lingwistyczna *36*
1.2.1.1 Analiza lingwistyczna *36*
1.1 Treść 36
1.2 Analiza grup czasownikowych 36
2. Słownik systemu *37*
Raport konfiguracji oprogramowania 39
Raport konfiguracji oprogramowania *39*
1.2.1.2 Raport konfiguracji oprogramowania *39*

Dokumentacja

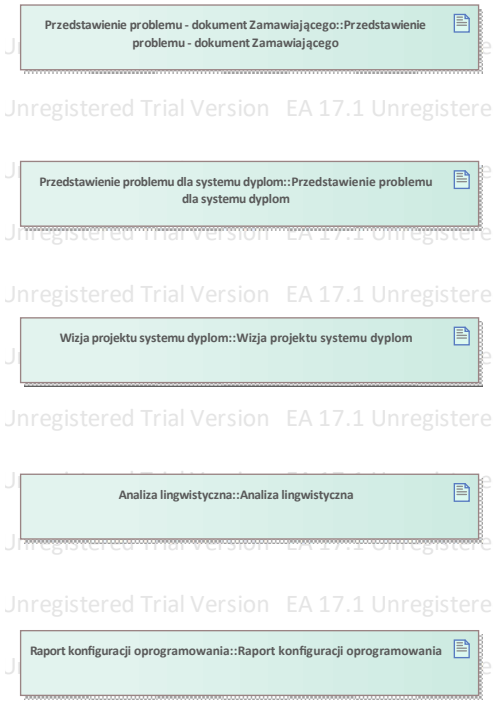
Package in package 'Etap A'

Dokumentacja
Version 1.0 Phase 1.0
andrzej.stasiak created on 08.01.2019. Last modified 08.01.2019

dokumentacja diagram

Documentation diagram in package 'Dokumentacja'

dokumentacja
Version 1.0
Piotr Popardowski created on 08.01.2019. Last modified 15.03.2026



Unregistered Trial Version EA 17.1 Unregistere

Figure 1: dokumentacja

Przedstawienie problemu - dokument Zamawiającego

Artifact in package 'Przedstawienie problemu - dokument Zamawiającego'

Przedstawienie problemu - dokument Zamawiającego
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 15.03.2026

1.1.1 Przedstawienie problemu - dokument zamawiającego

W naszej prywatnej klinice medycznej proces rezerwacji wizyt odbywa się obecnie w sposób tradycyjny, tj. telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji. Informacje o wizytach są zapisywane ręcznie w papierowym kalendarzu. Takie rozwiązanie działa od wielu lat, jednak wraz ze wzrostem liczby pacjentów zaczęło powodować coraz więcej problemów organizacyjnych.

Największą trudnością jest szybkie sprawdzenie dostępnych terminów u lekarzy. Recepcjonista musi każdorazowo przeglądać papierowy grafik, co wydłuża czas obsługi pacjenta. Zdarzają się również sytuacje, w których dochodzi do pomyłek lub podwójnych rezerwacji wizyt. W przypadku zmiany terminu wizyty lub jej odwołania konieczne jest ręczne poprawianie zapisków, co zwiększa ryzyko błędów.

Obecny sposób pracy powoduje także duże obciążenie pracowników recepcji. W godzinach największego ruchu odbierają oni wiele telefonów jednocześnie, a pacjenci muszą długo czekać na połączenie. Lekarze również nie mają wygodnego dostępu do swojego grafiku i często muszą sprawdzać go na miejscu w klinice, ponieważ jest dostępny jedynie w formie papierowej. Dodatkowym problemem jest brak możliwości łatwego przygotowania zestawień i raportów dotyczących funkcjonowania kliniki. Na przykład trudno jest szybko sprawdzić liczbę wizyt u poszczególnych lekarzy, liczbę odwołanych wizyt i stopień obciążenia grafiku. Takie informacje są istotne z punktu widzenia zarządzania kliniką.

Z tego powodu chcielibyśmy wprowadzić nowoczesny system informatyczny do obsługi rezerwacji wizyt lekarskich. System taki powinien umożliwiać prowadzenie elektronicznego grafiku lekarzy, szybkie sprawdzanie dostępnych terminów oraz rezerwację wizyt dla pacjentów. Ważne jest również, aby możliwe było łatwe zmienianie lub odwoływanie wizyt oraz kontrolowanie ich statusu. Dzięki takiemu rozwiązaniu liczymy przede wszystkim na usprawnienie pracy recepcji oraz skrócenie czasu obsługi pacjentów. System powinien również ograniczyć liczbę błędów w rezerwacjach i zapewnić przejrzysty dostęp do informacji o dostępnych terminach. Dodatkową korzyścią byłaby możliwość generowania prostych raportów, które pomogą w lepszym zarządzaniu pracą kliniki.Wdrożenie takiego systemu poprawiłoby organizację pracy, zwiększyło wygodę zarówno dla pacjentów, jak i pracowników, a także podniosło ogólną jakość obsługi w naszej placówce.

Przedstawienie problemu dla systemu dyplom

Artifact in package 'Przedstawienie problemu dla systemu dyplom'

Przedstawienie problemu dla systemu dyplom
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 15.03.2026

1. Cel działalności firmy

Celem Klinki Medycznej jest świadczenie profesjonalnych usług medycznych na wysokim poziomie przy jednoczesnym zapewnieniu wygody i krótkiego czasu oczekiwania dla pacjentów. Klinika dąży do optymalizacji procesów operacyjnych (zwłaszcza rejestracji i obsługi wizyt), poprawy dostępności terminów oraz zwiększenia efektywności pracy personelu medycznego i recepcji.

2. Opis firmy

Klinika działa w modelu prywatnym, obsługuje pacjentów ambulatoryjnie i oferuje konsultacje u specjalistów. Obecnie rezerwacje odbywają się telefonicznie i na miejscu — zapisy prowadzone są ręcznie w papierowym grafiku, co powoduje opóźnienia, błędy i utrudnia dostęp do statystyk. Wdrożenie elektronicznego systemu

rezerwacji ma na celu centralizację grafiku lekarzy, automatyzację obsługi pacjenta oraz ułatwienie raportowania i kontroli dostępności.

3. Aktorzy

3.1 Pacjent (Klient)

Końcowy użytkownik rezerwujący wizyt. Potrzebuje łatwego dostępu do dostępnych terminów i potwierdzeń.

3.2 Recepcjonista

Obsługa rezerwacji w imieniu pacjentów, zarządzanie zmianami i potwierdzeniami.

3.3 Lekarz

Udostępnia dostępność, akceptuje/edytyuje grafik, otrzymuje powiadomienia o zmianach.

3.4 Administrator

Użytkownik odpowiedzialny za zarządzanie kontami, uprawnieniami, konfiguracja systemu.

3.5 Kierownictwo kliniki / właściciel

Decydent biznesowy oczekujący raportów i metryk operacyjnych.

4. Procesy

Główne procesy realizowane przez system:

4.1 Rezerwacja wizyty:

Wyszukanie lekarza/terminu → wybór terminu → potwierdzenie → powiadomienie pacjenta i lekarza.

4.2 Zmiana / odwołanie wizyty:

Weryfikacja uprawnień → aktualizacja grafiku → notyfikacja zainteresowanych.

4.3 Zarządzanie grafikiem lekarzy:

Wprowadzanie dostępności, blokowanie terminów, zatwierdzanie wyjątków.

4.4 Rejestracja pacjenta:

Tworzenie, aktualizacja i zarządzanie danymi pacjenta, przypisanie historii wizyt.

4.5 Raportowanie:

Generowanie raportów administracyjnych (liczba wizyt, odwołań, obciążenie lekarzy).

5. Ograniczenia

5.1 Termin zakończenia projektu

Proponowany termin zakończenia (wersja docelowa przekazania do eksploatacji): 30 czerwca 2026. Termin można skorygować po szczegółowym planowaniu prac wdrożeniowych, testów i szkoleń.

5.2 Bezpieczeństwo danych osobowych

Ochrona danych osobowych pacjentów (również przy archiwizacji prac), zgodność z obowiązującymi przepisami.

5.3 Organizacyjne

Konieczność przeszkolenia personelu, ryzyko błędnej lub niepełnej specyfikacji wymagań, dostępność kompetentnego zespołu wdrożeniowego.

5.3 Techniczne

System musi działać w środowisku z przeglądarką internetową; wymagana kompatybilność z Windows i standardowymi konfiguracjami sieciowymi..

Wizja projektu systemu dyplom

Artifact in package 'Wizja projektu systemu dyplom'

Wizja projektu systemu dyplom
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 15.03.2026

System Rezerwacji Wizyt

Version <1.0>

[Uwaga: niebieski tekst kursywą zawarty w nawiasach kwadratowych zawiera wskazówki dla autora.]

[Aby dopasować pola automatyczne w programie Microsoft Word (pola te mają szare tło w momencie zaznaczenia) należy wybrać Plik->Właściwości oraz ustawić pola Tytuł, Temat i Firm. Po zamknięciu okna pola automatyczne mogą zostać zaktualizowane poprzez zaznaczenia całego dokumentu i naciśnięcie F. Czynności te należy powtórzyć również dla nagłówka i stopki dokumentu].

Historia dokumentu

Data	Wersja	Opis	Autor
2026/ 03/02	<1.0 >	System Rezerwacji Wizyt Lekarskich	Karolina Duras, Kacper Nowak, Mateusz Janiszewski

Spis treści

(Linked Document's Table Of Contents has been removed)

Wizja Projektu

1.1 Wstęp

Dokument opisuje planowany system informatyczny wspierający rezerwację wizyt lekarskich w prywatnej klinice. Dokument przedstawia cele biznesowe projektu, zakres systemu, identyfikuje udziałowców i użytkowników oraz definiuje najważniejsze ograniczenia i wymagania jakościowe.

1.1.1 Cel

Celem projektu jest usprawnienie procesu umawiania wizyt lekarskich poprzez wprowadzenie centralnego systemu rezerwacji, który umożliwi sprawdzanie dostępnych terminów, dokonywanie rezerwacji oraz zarządzanie grafikiem lekarzy w sposób kontrolowany.

1.1.2 Zakres

Projekt obejmuje zaprojektowanie systemu umożliwiającego:

- prowadzenie grafiku dostępności lekarzy,
- przegląd dostępnych terminów,
- rezerwację wizyt przez uprawnionych użytkowników,
- zmianę terminu wizyty,
- odwołanie wizyty,
- kontrolę statusów wizyt (np. zaplanowana / odwołana / zrealizowana / nieodbyta),
- podstawowe raporty organizacyjne (np. liczba wizyt na lekarza, liczba odwołań).

1.1.3 Definicje, akronimy, skróty

Pacjent – osoba korzystająca z usług medycznych.
Lekarz – pracownik medyczny posiadający specjalizację.
Wizyta – zdarzenie przypisane do pacjenta, lekarza i konkretnego terminu.

Grafik – zbiór dostępnych terminów lekarza.

Status wizyty – stan wizyty: zaplanowana, odwołana, zrealizowana, nieodbyta.

Recepcjonista – pracownik rejestracji obsługujący rezerwacje w imieniu pacjentów.

Administrator – użytkownik odpowiedzialny za konfigurację systemu i kont.

1.1.4 Dokumenty powiązane

- Specyfikacja wymagań systemowych
- Diagramy UML – tworzone w Enterprise Architect

1.1.5 Organizacja dokumentu

Dokument zawiera opis celów biznesowych, problemu i potrzeb, identyfikację udziałowców oraz użytkowników, a także kluczowe ograniczenia i wymagania jakościowe projektu.

1.2 Założenia projektu (Positioning)

1.2.1 Cele biznesowe

Aktualnie proces rezerwacji wizyt odbywa się telefonicznie lub osobiście w recepcji. Wizyty są odnotowywane w papierowym notesie. Powoduje to:

- trudności w szybkim sprawdzeniu dostępnych terminów,
- ryzyko podwójnych rezerwacji,
- duże obciążenie recepcji,
- brak spójnych raportów (np. obciążenie lekarzy, liczba odwołań)
- lekarz musi sprawdzać grafik stacjonarnie na papierze
- powolna procedura powiadomienia o ewentualnych zmianach terminu, zarówno lekarzy jak i pacjentów

Po wdrożeniu systemu oczekuje się:

- skrócenia czasu rezerwacji wizyty,
- odciążenie recepcji,
- lepsze dostosowanie pacjeta do odpowiedniego specjalisty,
- zmniejszenia liczby błędów organizacyjnych,
- lepszej kontroli dostępności terminów,
- możliwości przygotowania prostych raportów zarządczych.

1.2.2 Opis problemu/potrzeby

Problem z	manualnym procesem umawiania wizyt i zarządzania grafikiem lekarzy
Dotyczy	pacjentów, recepcjonistów, lekarzy
o znaczeniu	powoduje błędy w rezerwacjach, zwiększa obciążenie pracowników recepcji oraz pogarsza dostęp pacjentów do informacji o terminach.
pomyślnym rozwiązaniem byłoby	• wdrożenie centralnego systemu rezerwacji wizyt, • automatyczna kontrola dostępności terminów, • jednoznaczne przypisanie wizyty do pacjenta i lekarza,

	• możliwość odwołania i zmiany terminu, • generowanie prostych raportów.

1.2.3 Product Position Statement (jak to przetłumaczyć). Nie wiem czy tego kawałka nie wywalić

[Ogólne podsumowanie na wysokim poziome, określające unikalną potrzebę jaką produkt ma rozwiązać.. Można użyć poniższego formatu.]

Dla	Prywatna klinika medyczna
Kto/co	Która chce usprawnić proces umawiania wizyt
Nazwa produktu	XYZ
Takim, że	Poprzez system rezerwacji wizyt lekarskich, który umożliwia centralne zarządzanie grafikiem lekarzy oraz rezerwacjami pacjentów.
W przeciwieństwie do	Do rejestracji telefonicznej i papierowych kalendarzy
Nasz produkt	Ogranicza ryzyko podwójnych rezerwacji, skraca czas obsługi oraz zapewnia przejrzysty przegląd dostępnych terminów.

[A product position statement communicates the intent of the application and the importance of the project to all concerned personnel.]

1.3 Udziałowcy i użytkownicy

[Aby dostarczyć produkt i usługi spełniający wymagania udziałowców i użytkowników, niezbędna jest ich identyfikacja i uwzględnienie podczas procesu modelowania.. Sekcja ta zwiera profile udziałowców i użytkowników zaangażowanych w projekt oraz główny problemy które chcieliby rozwiązać.]

1.3.1 Udziałowcy

[Poniżej powinna się znaleźć list udziałowców nie będących użytkownikami końcowymi projektu.]

Właściciel kliniki	Inwestor projektu	Określa cele, zatwierdza budżet i zakres, monitoruje postępy

Kierownik	Odpowiada za funkcjonowanie kliniki	Określa potrzeby operacyjne i proceduralne

1.3.2 Użytkownicy

[Lista zidentyfikowanych użytkowników.]

Pacjent	Osoba rezerwująca wizyty	Rezerwuje / odwołuje wizyty	Kierownik rejestracji
Recepcjonista	Pracownik rejestracji	Rezerwuje wizyty w imieniu pacjentów, zarządza zmianami, informuje o zmianach, udziela informacji o wizytach.	Kierownik rejestracji
Lekarz	Realizuje wizyty	Udostępnia dostępność (lub akceptuje grafik)	Kierownik rejestracji
Administrator	Utrzymanie systemu	Zarządza kontami, uprawnieniami i konfiguracją	Właściciel
[Nazwa typu użytkownika.]	[Opis użytkownika w stosunku do systemu.]	[Lista głównych odpowiedzialności użytkownika w stosunku do wytwarzanego systemu; na przykład: - tworzy raporty - koordynuje pracę - i tym podobne]	[Jeżeli użytkownik nie jest bezpośrednio reprezentowany, zidentyfikuj udziałowca odpowiedzialnego za interesy użytkownika.]

1.3.3 Środowisko użytkownika

[Opisz środowisko pracy użytkownika końcowego. Poniżej znajdują się pewne sugestie:

- Ilość osób biorących udział w zadaniu? Czy ta liczba jest zmienna?
- Jak długo trwa cykl dla zadania? Ile czasu trwa każda aktywność? Czy jest to zmienne?
- Ograniczenia środowiska: mobilny, poza-biurem, itp.?
- Jakie platformy systemowe są używane? Jakie będą używane w przyszłości?
- Jakie inne aplikacje są używane? Czy Twoja aplikacja musi się z nimi integrować?

.]

- Ilość osób biorących udział w zadaniu jest zmienna przez fakt, że zmienna jest ilość pacjentów w przeciwieństwie do lekarzy i recepcjonistów

- Czas trwania aktywności może być różna i może zależeć od tego jaki typ użytkownika będzie z niego korzystać
- ?
- Używana jest przeglądarka internetowa. W przyszłości planowane jest połączenie systemu z wersją mobilną oraz systemem, który automatycznie przypomina o wizytach oraz informuje o zmianach
- Aktualnie żadna inna aplikacja nie jest używana

1.3.4 Profile udziałowców

[Opisz każdego udziałowca za pomocą poniższej tabeli.]

1.3.4.1 <Nazwa udziałowca>

Reprezentant	[Kto reprezentuje tego udziałowca w naszym projekcie? Powinny znaleźć się tutaj nazwiska osób.] To ma być imię i nazwisko jednej osoby z naszego projektu? XD
Opis	[Krótki opis typu udziałowca] Właściciel
Rodzaj	[Określenie doświadczenia, wiedzy technicznej oraz poziomu zaawansowanie udziałowca. Np. guru, biznes, export, zwykły użytkownik ,itp.] Duże doświadczenie biznesowe, inwestor projektu, brak wiedzy technicznej
Odpowiedzialności	[List odpowiedzialności (oraz interesów) w stosunku do naszego systemu.] System bezpośrednio przekłada się na pracę kliniki, która jest jego własnością
Czynniki sukcesu	[Jak użytkownik definiuje sukces? W jaki sposób jest wynagradzany?] Zwiększenie satysfakcji klienta oraz pracowników
Zaangażowanie	[Jak bardzo jest zaangażowany w projekt? Określ jego rolę w projekcie.] Zatwierdza główną idee projektu. Finansuje projekt
Produkty	[Czy istnieją jakiekolwiek produkty które tworzy – jeżeli tak to dla kogo?] Nie
Komentarze i problemy	[List odpowiedzialności (oraz interesów) w stosunku do naszego systemu.] System bezpośrednio przekłada się na pracę kliniki, która jest jego własnością

Reprezentant	[Kto reprezentuje tego udziałowca w naszym projekcie? Powinny znaleźć się tutaj nazwiska osób.]
Opis	[Krótki opis typu udziałowca] Kierownik kliniki
Rodzaj	[Określenie doświadczenia, wiedzy technicznej oraz poziomu zaawansowanie udziałowca. Np. guru, biznes, export, zwykły użytkownik ,itp.] Duże doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu projektami, brak wiedzy technicznej
Odpowiedzialności	[List odpowiedzialności (oraz interesów) w stosunku do naszego systemu.]

	System bezpośrednio przekłada się na pracę kliniki, za którą jest odpowiedzialny
Czynniki sukcesu	[Jak użytkownik definiuje sukces? W jaki sposób jest wynagradzany?] Zwiększenie satysfakcji klienta oraz pracowników
Zaangażowanie	[Jak bardzo jest zaangażowany w projekt? Określ jego rolę w projekcie.] Szuka osób/firmy które wykonają projekt
Produkty	[Czy istnieją jakiekolwiek produkty które tworzy – jeżeli tak to dla kogo?] Nie
Komentarze i problemy	[List odpowiedzialności (oraz interesów) w stosunku do naszego systemu.] System bezpośrednio przekłada się na pracę kliniki, za którą jest odpowiedzialny

1.3.5 Profile użytkowników

[Opisz każdy unikalny rodzaj użytkownika według poniższej tabeli.]

1.3.5.1 <Nazwa użytkownika>

Reprezentant	[Kto jest reprezentantem użytkownika w projekcie ? Często odnosi się do udziałowca reprezentującego ten typ uczestnika końcowego.]
Opis	[Opis typu użytkownika.] Klient
Rodzaj	[Określenie doświadczenia, wiedzy technicznej oraz poziomu zaawansowanie użytkownika. Np. guru, zwykły użytkownik ,itp.] Zwykły użytkownik
Odpowiedzialności	[List odpowiedzialności (oraz interesów) w stosunku do naszego systemu.] brak
Czynniki sukcesu	[Jak użytkownik definiuje sukces? W jaki sposób jest wynagradzany?] Łatwiejsze ustalanie wizyt
Zaangażowanie	[Jak bardzo jest zaangażowany w projekt? Określ jego rolę w projekcie.] Opiniuje projekt
Produkty	[Czy istnieją jakiekolwiek produkty które tworzy – jeżeli tak to dla kogo?] Nie
Komentarze i problemy	[Problemy które mogą zakłócić sukces projektu i pozostałe komentarze] Brak

Reprezentant	[Kto jest reprezentantem użytkownika w projekcie ? Często odnosi się do udziałowca reprezentującego ten typ uczestnika końcowego.]
Opis	[Opis typu użytkownika.] Lekarz

Rodzaj	[Określenie doświadczenia, wiedzy technicznej oraz poziomu zaawansowanie użytkownika. Np. guru, zwykły użytkownik ,itp.] Zwykły użytkownik
Odpowiedzialności	[List odpowiedzialności (oraz interesów) w stosunku do naszego systemu.] Opiniuje
Czynniki sukcesu	[Jak użytkownik definiuje sukces? W jaki sposób jest wynagradzany?] Łatwość w sprawdzaniu grafika
Zaangażowanie	[Jak bardzo jest zaangażowany w projekt? Określ jego rolę w projekcie.] Przedstawia oczekiwania
Produkty	[Czy istnieją jakiekolwiek produkty które tworzy – jeżeli tak to dla kogo?] Nie
Komentarze i problemy	[Problemy które mogą zakłócić sukces projektu i pozostałe komentarze] Brak

Reprezentant	[Kto jest reprezentantem użytkownika w projekcie ? Często odnosi się do udziałowca reprezentującego ten typ uczestnika końcowego.]
Opis	[Opis typu użytkownika.] Recepcjonista/Recepcjonistka
Rodzaj	[Określenie doświadczenia, wiedzy technicznej oraz poziomu zaawansowanie użytkownika. Np. guru, zwykły użytkownik ,itp.] Główny użytkownik z wiedzą o harmonogramach i zarządzaniu informacją odnośnie wizyt
Odpowiedzialności	[List odpowiedzialności (oraz interesów) w stosunku do naszego systemu.] Wspiera tworzenie narzędzia
Czynniki sukcesu	[Jak użytkownik definiuje sukces? W jaki sposób jest wynagradzany?] Odciążenie jego pracy
Zaangażowanie	[Jak bardzo jest zaangażowany w projekt? Określ jego rolę w projekcie.] Opiniuje oraz przedstawia potrzeby
Produkty	[Czy istnieją jakiekolwiek produkty które tworzy – jeżeli tak to dla kogo?] Nie
Komentarze i problemy	[Problemy które mogą zakłócić sukces projektu i pozostałe komentarze]

1.3.6 Główni uczestnicy lub potrzeby klienta

[Wymień główne problemy w istniejących rozwiązaniach z punktu widzenia udziałowca. Dla każdego problemu udziel odpowiedzi na następujące pytania:

- Jakie są przyczyny problemu?

- Jak jest rozwiązywany w chwili obecnej?
- Jakiego rozwiązania oczekuje klient?]

[Istotne jest zrozumienia względnego priorytetu jaki udziałowiec przydziela każdemu problemowi. Należy zidentyfikować problemy które muszą być rozwiązane oraz te którymi udziałowcy chcieliby żeby się zająć.

Wypełnij poniższą tabele.]

1.3.7 Alternatywy i konkurencja

[Identyfikacja alternatywnych rozwiązań z punktu widzenia udziałowców. Powinna uwzględniać zakup produktu konkurencji, stworzenie tymczasowego rozwiązania lub utrzymania istniejącej systuacji .Wymień wszystkie konkurencyjne rozwiązania które istnieją lub mogą zaistnieć. Opisz ich głowne wady i zalety z punktu widzenia udziałowca]

1.4 Ograniczenia

[Wymień wszystkie ograniczenia projektowe, zewnętrzne oraz inne zależności.]

- Największym zagrożeniem jest dobranie grupy specjalistów którzy stworzą odpowiedni system,
- Oraz złe lub niepełne przedstawienie problemów

1.5 Wymagania jakości

[Zdefiniuj wymagania jakościowe dla wydajności, niezawodności, obciążania, użyteczności i podobnych charakterystyk.]

- System musi pracować nieprzerwanie w dni w których klinika pracuje,
- Wytrzymać obciążenia systemowe recepcji oraz klientów,
- Musi działać płynnie i szybko
- Musi być przejrzysta, spełniać standardy wizualne,
- Musi być intuicyjna dla użytkownika końcowego

1.6 Priorytety

[Określ priorytety dla celów projektu.]

1.7 Pozostałe wymagania

[Wymagania sprzętowe i systemowe, wymagania środowiskowe, istniejące standardy.]

1.7.1 Stosowane standardy

[Lista wszystkich standardów do których należy się dostosować Dotyczy to standardów prawnych (FDA, UCC), komunikacyjnych (TCP/IP, ISDN), systemowych (Windows, UNIX, and so on), jakości (UL, ISO, CMM) itp..]

- Baza pacjentów oraz pracowników na której będzie oparty system musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa ze względu na wrażliwe dane, które będą zawarte w bazie,
- System musi być dostępny dla systemu Windows

1.7.2 Wymagania systemowe i sprzętowe

[Wymagania sprzętowe I systemowe niezbędne do działania aplikacji. Dotyczy to oprogramowania, platform sieciowych, konfiguracji.]

1.7.3 Wymagania wydajnościowe

[Lista wszystkich wymagań wydajnościowych. Może zawierać takie elementy jak: szerokość łącza, maksymalna ilość użytkowników, przepustowość, precyzję, czas odpowiedzi itp.]

1.7.4 Wymagania związane ze środowiskiem pracy

Brak

Analiza lingwistyczna

Artifact in package 'Analiza lingwistyczna'

Analiza lingwistyczna
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 15.03.2026

1.1 Analiza lingwistyczna

1.1 Treść

Właściciel prywatnej kliniki „Klinka Medyczna” zlecił firmie informatycznej realizację projektu pod nazwą „System Rezerwacji Wizyt” (SRW). Podstawowym celem systemu będzie usprawnienie procesu rejestracji pacjentów oraz zarządzania grafikiem pracy lekarzy w klinice.

Klinika Medyczna świadczy usługi konsultacji specjalistycznych dla pacjentów prywatnych. W chwili obecnej proces umawiania wizyt odbywa się telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji kliniki. Recepcjoniści zapisują wizyty w papierowym kalendarzu zawierającym grafik lekarzy oraz dostępne terminy.
Klinika uznała, że potrzebny jest system informatyczny SRW wspierający pracę recepcji, lekarzy oraz poprawiający obsługę pacjentów. System ma umożliwiać prowadzenie elektronicznego grafiku pracy lekarzy, przeglądanie dostępnych terminów wizyt oraz dokonywanie rezerwacji wizyt dla pacjentów. Z systemu korzystać będą pracownicy recepcji, którzy będą mogli zapisywać pacjentów na wizyty, zmieniać terminy wizyt oraz odwoływać wizyty w przypadku rezygnacji pacjenta.

System powinien również umożliwiać lekarzom sprawdzanie ich aktualnego grafiku wizyt oraz dostępności terminów. Dzięki temu lekarz będzie miał szybki dostęp do informacji o zaplanowanych wizytach oraz obciążeniu swojego harmonogramu pracy.

Wprowadzenie systemu SRW powinno również usprawnić organizację pracy w klinice. Informacje o wizytach będą dostępne w jednym centralnym systemie informatycznym, co ograniczy liczbę błędów oraz ułatwi kontrolę nad dostępnością terminów. Dodatkowo system umożliwi generowanie prostych raportów dotyczących liczby wizyt, liczby odwołań wizyt oraz obciążenia poszczególnych lekarzy.

1.2 Analiza grup czasownikowych

Grupy czasownikowe	Usługa (przypadek użycia)	Operacja lub odpowiedzialność
zlecił		Zlecanie
realizację		Realizacja
usprawnienie		usprawnienie
zarządzania grafikiem pracy	Zarządzania grafikiem pracy	
świadczy		Świadczenie
zapisują		Zapisywanie
uznała		
wspierający pracę recepcji,	wspieranie pracy recepcji	

poprawiający obsługę pacjentów	poprawienie obsługi pacjentów	
prowadzenie	Prowadzenie grafiku pracy	
dokonywanie rezerwacji wizyt	rezerwacja wizyty	
umożliwi generowanie prostych raportów	generowanie raportów	
odwołań wizyt	odwoływanie wizyt	

1.2 Analiza grup rzeczownikowych

Grupy rzeczownikowe	Kandydat na obiekt	Kandydat na atrybut
właściciel	właściciel	
Klinika Medyczna	klinika	
firma informatyczna	firma informatyczna	
System Rezerwacji Wizyt (SRW)	System Rezerwacji Wizyt	SRW
pacjentów	pacjent	
lekarzy	lekarz	
klinice		
konsultacji specjalistycznych	konsultacja specjalistyczna	
recepcji kliniki	recepcja	
recepcjoniści	recepcjonista	
papierowym kalendarzu	papierowy kalendarz	
grafik lekarzy	grafik pracy lekarzy	
dostępne terminy	grafik wizyt	
klinika		
system informatyczny SRW		
system		
elektronicznego grafiku pracy lekarzy		
dostępnych terminów wizyt		
wizyt	wizyta	
terminy wizyt		
wizyty		
rezygnacji pacjenta	rezygnacja z wizyty	
lekarzom		
grafiku wizyt		
dostępności terminów		
wizytach		
harmonogramu pracy		
systemu SRW		
systemie informatycznym		
raportów	report	
wizyt		
lekarzy		

2. Słownik systemu

** Pacjent jest klientem kliniki, który jest jednoznacznie charakteryzowany przez swój numer PESEL
Pacjent = @PESEL + imię + nazwisko + data urodzenia + płeć + {wizyty}

Płeć = [kobieta | mężczyzna]

** Lekarz jest pracownikiem kliniki, który udziela usług medycznych pacjentom. Jest jednoznacznie identyfikowany przez numer pracownika

Lekarz = @Numer pracownika + imię + nazwisko + {specjalizacja} + numer gabinetu + płaca + grafik

** Recepcjonista jest pracownikiem kliniki, który odpowiada za część logistyczną pracy kliniki. Jest jednoznacznie identyfikowany przez numer pracownika
Recepcjonista = @Numer pracownika + imię + nazwisko + płaca + grafik

** Grafik określa harmonogram pracy pracownika kliniki
Grafik = numer pracownika + data + godzina rozpoczęcia + godzina zakończenia + typ wpisu

Typ wpisu = [praca | urlop płatny | urlop bezpłatny | zwolnienie lekarskie]

** Wizyta jest pojedyńczą jednostką świadczenia usług medycznych pacjentom przez lekarzy
Wizyta = @numer wizyty + rodzaj usługi + data + czas trwania + pacjent + lekarz + status wizyty + cena

Status wizyty = [zaplanowana | zrealizowana | odwołana | nieodbyta]

Raport konfiguracji oprogramowania

Artifact in package 'Raport konfiguracji oprogramowania'

Raport konfiguracji oprogramowania
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 10.02.2019

1.2 Raport konfiguracji oprogramowania

...

Dokumenty etapu definicji

Package in package 'Dokumentacja'

Dokumenty etapu definicji
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 10.02.2019

Przedstawienie problemu - dokument Zamawiającego

Package in package 'Dokumenty etapu definicji'

Przedstawienie problemu - dokument Zamawiającego
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 10.02.2019

Przedstawienie problemu - dokument Zamawiającego

Artifact in package 'Przedstawienie problemu - dokument Zamawiającego'

Przedstawienie problemu - dokument Zamawiającego
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 15.03.2026

1.1.1.1.1 Przedstawienie problemu - dokument zamawiającego

W naszej prywatnej klinice medycznej proces rezerwacji wizyt odbywa się obecnie w sposób tradycyjny, tj. telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji. Informacje o wizytach są zapisywane ręcznie w papierowym kalendarzu. Takie rozwiązanie działa od wielu lat, jednak wraz ze wzrostem liczby pacjentów zaczęło powodować coraz więcej problemów organizacyjnych.

Największą trudnością jest szybkie sprawdzenie dostępnych terminów u lekarzy. Recepcjonista musi każdorazowo przeglądać papierowy grafik, co wydłuża czas obsługi pacjenta. Zdarzają się również sytuacje, w których dochodzi do pomyłek lub podwójnych rezerwacji wizyt. W przypadku zmiany terminu wizyty lub jej odwołania konieczne jest ręczne poprawianie zapisków, co zwiększa ryzyko błędów.

Obecny sposób pracy powoduje także duże obciążenie pracowników recepcji. W godzinach największego ruchu odbierają oni wiele telefonów jednocześnie, a pacjenci muszą długo czekać na połączenie. Lekarze również nie mają wygodnego dostępu do swojego grafiku i często muszą sprawdzać go na miejscu w klinice, ponieważ jest dostępny jedynie w formie papierowej. Dodatkowym problemem jest brak możliwości łatwego przygotowania zestawień i raportów dotyczących funkcjonowania kliniki. Na przykład trudno jest szybko sprawdzić liczbę wizyt u poszczególnych lekarzy, liczbę odwołanych wizyt i stopień obciążenia grafiku. Takie informacje są istotne z punktu widzenia zarządzania kliniką.

Z tego powodu chcielibyśmy wprowadzić nowoczesny system informatyczny do obsługi rezerwacji wizyt lekarskich. System taki powinien umożliwiać prowadzenie elektronicznego grafiku lekarzy, szybkie sprawdzanie dostępnych terminów oraz rezerwację wizyt dla pacjentów. Ważne jest również, aby możliwe było łatwe zmienianie lub odwoływanie wizyt oraz kontrolowanie ich statusu. Dzięki takiemu rozwiązaniu liczymy przede wszystkim na usprawnienie pracy recepcji oraz skrócenie czasu obsługi pacjentów. System powinien również ograniczyć liczbę błędów w rezerwacjach i zapewnić przejrzysty dostęp do informacji o dostępnych terminach. Dodatkową korzyścią byłaby możliwość generowania prostych raportów, które pomogą w lepszym zarządzaniu pracą kliniki.Wdrożenie takiego systemu poprawiłoby organizację pracy, zwiększyło wygodę zarówno dla pacjentów, jak i pracowników, a także podniosło ogólną jakość obsługi w naszej placówce.

Przedstawienie problemu dla systemu dyplom

Package in package 'Dokumenty etapu definicji'

Przedstawienie problemu dla systemu dyplom
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 10.02.2019

Przedstawienie problemu dla systemu dyplom

Artifact in package 'Przedstawienie problemu dla systemu dyplom'

Przedstawienie problemu dla systemu dyplom
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 15.03.2026

1. Cel działalności firmy

Celem Klinki Medycznej jest świadczenie profesjonalnych usług medycznych na wysokim poziomie przy jednoczesnym zapewnieniu wygody i krótkiego czasu oczekiwania dla pacjentów. Klinika dąży do optymalizacji procesów operacyjnych (zwłaszcza rejestracji i obsługi wizyt), poprawy dostępności terminów oraz zwiększenia efektywności pracy personelu medycznego i recepcji.

2. Opis firmy

Klinika działa w modelu prywatnym, obsługuje pacjentów ambulatoryjnie i oferuje konsultacje u specjalistów. Obecnie rezerwacje odbywają się telefonicznie i na miejscu — zapisy prowadzone są ręcznie w papierowym grafiku, co powoduje opóźnienia, błędy i utrudnia dostęp do statystyk. Wdrożenie elektronicznego systemu rezerwacji ma na celu centralizację grafiku lekarzy, automatyzację obsługi pacjenta oraz ułatwienie raportowania i kontroli dostępności.

3. Aktorzy

3.1 Pacjent (Klient)

Końcowy użytkownik rezerwujący wizyt. Potrzebuje łatwego dostępu do dostępnych terminów i potwierdzeń.

3.2 Recepcjonista

Obsługa rezerwacji w imieniu pacjentów, zarządzanie zmianami i potwierdzeniami.

3.3 Lekarz

Udostępnia dostępność, akceptuje/edytuje grafik, otrzymuje powiadomienia o zmianach.

3.4 Administrator

Użytkownik odpowiedzialny za zarządzanie kontami, uprawnieniami, konfiguracja systemu.

3.5 Kierownictwo kliniki / właściciel

Decydent biznesowy oczekujący raportów i metryk operacyjnych.

4. Procesy

Główne procesy realizowane przez system:

4.1 Rezerwacja wizyty:

Wyszukanie lekarza/terminu → wybór terminu → potwierdzenie → powiadomienie pacjenta i lekarza.

4.2 Zmiana / odwołanie wizyty:

Weryfikacja uprawnień → aktualizacja grafiku → notyfikacja zainteresowanych.

4.3 Zarządzanie grafikiem lekarzy:

Wprowadzanie dostępności, blokowanie terminów, zatwierdzanie wyjątków.

4.4 Rejestracja pacjenta:

Tworzenie, aktualizacja i zarządzanie danymi pacjenta, przypisanie historii wizyt.

4.5 Raportowanie:

Generowanie raportów administracyjnych (liczba wizyt, odwołań, obciążenie lekarzy).

5. Ograniczenia

5.1 Termin zakończenia projektu

Proponowany termin zakończenia (wersja docelowa przekazania do eksploatacji): 30 czerwca 2026. Termin można skorygować po szczegółowym planowaniu prac wdrożeniowych, testów i szkoleń.

5.2 Bezpieczeństwo danych osobowych

Ochrona danych osobowych pacjentów (również przy archiwizacji prac), zgodność z obowiązującymi przepisami.

5.3 Organizacyjne

Konieczność przeszkolenia personelu, ryzyko błędnej lub niepełnej specyfikacji wymagań, dostępność kompetentnego zespołu wdrożeniowego.

5.3 Techniczne

System musi działać w środowisku z przeglądarką internetową; wymagana kompatybilność z Windows i standardowymi konfiguracjami sieciowymi..

Wizja projektu systemu dyplom

Package in package 'Dokumenty etapu definicji'

Wizja projektu systemu dyplom
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 10.02.2019

Wizja projektu systemu dyplom

Artifact in package 'Wizja projektu systemu dyplom'

Wizja projektu systemu dyplom
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 15.03.2026

System Rezerwacji Wizyt

Version <1.0>

[Uwaga: niebieski tekst kursywą zawarty w nawiasach kwadratowych zawiera wskazówki dla autora.]

[Aby dopasować pola automatyczne w programie Microsoft Word (pola te mają szare tło w momencie zaznaczenia) należy wybrać Plik->Właściwości oraz ustawić pola Tytuł, Temat i Firm. Po zamknięciu okna pola automatyczne mogą zostać zaktualizowane poprzez zaznaczenia całego dokumentu i naciśnięcie F. Czynności te należy powtórzyć również dla nagłówka i stopki dokumentu].

Historia dokumentu

Data	Wersja	Opis	Autor
2026/ 03/02	<1.0 >	System Rezerwacji Wizyt Lekarskich	Karolina Duras, Kacper Nowak, Mateusz Janiszewski

Spis treści

(Linked Document's Table Of Contents has been removed)

Wizja Projektu

1.7.4.1 Wstęp

Dokument opisuje planowany system informatyczny wspierający rezerwację wizyt lekarskich w prywatnej klinice. Dokument przedstawia cele biznesowe projektu, zakres systemu, identyfikuje udziałowców i użytkowników oraz definiuje najważniejsze ograniczenia i wymagania jakościowe.

1.7.4.1.1 Cel

Celem projektu jest usprawnienie procesu umawiania wizyt lekarskich poprzez wprowadzenie centralnego systemu rezerwacji, który umożliwi sprawdzanie dostępnych terminów, dokonywanie rezerwacji oraz zarządzanie grafikiem lekarzy w sposób kontrolowany.

1.7.4.1.2 Zakres

Projekt obejmuje zaprojektowanie systemu umożliwiającego:

- prowadzenie grafiku dostępności lekarzy,
- przegląd dostępnych terminów,
- rezerwację wizyt przez uprawnionych użytkowników,
- zmianę terminu wizyty,
- odwołanie wizyty,
- kontrolę statusów wizyt (np. zaplanowana / odwołana / zrealizowana / nieodbyta),
- podstawowe raporty organizacyjne (np. liczba wizyt na lekarza, liczba odwołań).

1.7.4.1.3 Definicje, akronimy, skróty

Pacjent – osoba korzystająca z usług medycznych.
Lekarz – pracownik medyczny posiadający specjalizację.
Wizyta – zdarzenie przypisane do pacjenta, lekarza i konkretnego terminu.

Grafik – zbiór dostępnych terminów lekarza.

Status wizyty – stan wizyty: zaplanowana, odwołana, zrealizowana, nieodbyta.

Recepcjonista – pracownik rejestracji obsługujący rezerwacje w imieniu pacjentów.

Administrator – użytkownik odpowiedzialny za konfigurację systemu i kont.

1.7.4.1.4 Dokumenty powiązane

- Specyfikacja wymagań systemowych
- Diagramy UML – tworzone w Enterprise Architect

1.7.4.1.5 Organizacja dokumentu

Dokument zawiera opis celów biznesowych, problemu i potrzeb, identyfikację udziałowców oraz użytkowników, a także kluczowe ograniczenia i wymagania jakościowe projektu.

1.7.4.2 Założenia projektu (Positioning)

1.7.4.2.1 Cele biznesowe

Aktualnie proces rezerwacji wizyt odbywa się telefonicznie lub osobiście w recepcji. Wizyty są odnotowywane w papierowym notesie. Powoduje to:

- trudności w szybkim sprawdzeniu dostępnych terminów,
- ryzyko podwójnych rezerwacji,
- duże obciążenie recepcji,
- brak spójnych raportów (np. obciążenie lekarzy, liczba odwołań)
- lekarz musi sprawdzać grafik stacjonarnie na papierze
- powolna procedura powiadomienia o ewentualnych zmianach terminu, zarówno lekarzy jak i pacjentów

Po wdrożeniu systemu oczekuje się:

- skrócenia czasu rezerwacji wizyty,
- odciążenie recepcji,
- lepsze dostosowanie pacjeta do odpowiedniego specjalisty,
- zmniejszenia liczby błędów organizacyjnych,
- lepszej kontroli dostępności terminów,
- możliwości przygotowania prostych raportów zarządczych.

1.7.4.2.2 Opis problemu/potrzeby

Problem z	manualnym procesem umawiania wizyt i zarządzania grafikiem lekarzy
Dotyczy	pacjentów, recepcjonistów, lekarzy
o znaczeniu	powoduje błędy w rezerwacjach, zwiększa obciążenie pracowników recepcji oraz pogarsza dostęp pacjentów do informacji o terminach.
pomyślnym rozwiązaniem byłoby	• wdrożenie centralnego systemu rezerwacji wizyt, • automatyczna kontrola dostępności terminów, • jednoznaczne przypisanie wizyty do pacjenta i lekarza, • możliwość odwołania i zmiany terminu, • generowanie prostych raportów.

1.7.4.2.3 Product Position Statement (jak to przetłumaczyć). Nie wiem czy tego kawałka nie wywalić

[Ogólne podsumowanie na wysokim poziome, określające unikalną potrzebę jaką produkt ma rozwiązać.. Można użyć poniższego formatu.]

Dla	Prywatna klinika medyczna
Kto/co	Która chce usprawnić proces umawiania wizyt
Nazwa produktu	XYZ
Takim, że	Poprzez system rezerwacji wizyt lekarskich, który umożliwia centralne zarządzanie grafikiem lekarzy oraz rezerwacjami pacjentów.
W przeciwieństwie do	Do rejestracji telefonicznej i papierowych kalendarzy
Nasz produkt	Ogranicza ryzyko podwójnych rezerwacji, skraca czas obsługi oraz zapewnia przejrzysty przegląd dostępnych terminów.

[A product position statement communicates the intent of the application and the importance of the project to all concerned personnel.]

1.7.4.3 Udziałowcy i użytkownicy

[Aby dostarczyć produkt i usługi spełniający wymagania udziałowców i użytkowników, niezbędna jest ich identyfikacja i uwzględnienie podczas procesu modelowania.. Sekcja ta zwiera profile udziałowców i użytkowników zaangażowanych w projekt oraz główny problemy które chcieliby rozwiązać.]

1.7.4.3.1 Udziałowcy

[Poniżej powinna się znaleźć list udziałowców nie będących użytkownikami końcowymi projektu.]

Właściciel kliniki	Inwestor projektu	Określa cele, zatwierdza budżet i zakres, monitoruje postępy
Kierownik	Odpowiada za funkcjonowanie kliniki	Określa potrzeby operacyjne i proceduralne

1.7.4.3.2 Użytkownicy

[Lista zidentyfikowanych użytkowników.]

Pacjent	Osoba rezerwująca wizyty	Rezerwuje / odwołuje wizyty	Kierownik rejestracji
Recepcjonista	Pracownik rejestracji	Rezerwuje wizyty w imieniu pacjentów, zarządza zmianami, informuje o zmianach, udziela informacji o wizytach.	Kierownik rejestracji

Lekarz	Realizuje wizyty	Udostępnia dostępność (lub akceptuje grafik)	Kierownik rejestracji
Administrator	Utrzymanie systemu	Zarządza kontami, uprawnieniami i konfiguracją	Właściciel
[Nazwa typu użytkownika.]	[Opis użytkownika w stosunku do systemu.]	[Lista głównych odpowiedzialności użytkownika w stosunku do wytwarzanego systemu; na przykład: - tworzy raporty - koordynuje pracę - i tym podobne]	[Jeżeli użytkownik nie jest bezpośrednio reprezentowany, zidentyfikuj udziałowca odpowiedzialnego za interesy użytkownika.]

1.7.4.3.3 Środowisko użytkownika

[Opisz środowisko pracy użytkownika końcowego. Poniżej znajdują się pewne sugestie:

- Ilość osób biorących udział w zadaniu? Czy ta liczba jest zmienna?
- Jak długo trwa cykl dla zadania? Ile czasu trwa każda aktywność? Czy jest to zmienne?
- Ograniczenia środowiska: mobilny, poza-biurem, itp.?
- Jakie platformy systemowe są używane? Jakie będą używane w przyszłości?
- Jakie inne aplikacje są używane? Czy Twoja aplikacja musi się z nimi integrować?

.]

- Ilość osób biorących udział w zadaniu jest zmienna przez fakt, że zmienna jest ilość pacjentów w przeciwieństwie do lekarzy i recepcjonistów
- Czas trwania aktywności może być różna i może zależeć od tego jaki typ użytkownika będzie z niego korzystać
- ?
- Używana jest przeglądarka internetowa. W przyszłości planowane jest połączenie systemu z wersją mobilną oraz systemem, który automatycznie przypomina o wizytach oraz informuje o zmianach
- Aktualnie żadna inna aplikacja nie jest używana

1.7.4.3.4 Profile udziałowców

[Opisz każdego udziałowca za pomocą poniższej tabeli.]

1.7.4.3.4.1 <Nazwa udziałowca>

Reprezentant	[Kto reprezentuje tego udziałowca w naszym projekcie? Powinny znaleźć się tutaj nazwiska osób.] To ma być imię i nazwisko jednej osoby z naszego projektu? XD
Opis	[Krótki opis typu udziałowca] Właściciel
Rodzaj	[Określenie doświadczenia, wiedzy technicznej oraz poziomu zaawansowanie udziałowca. Np. guru, biznes, export, zwykły użytkownik ,itp.] Duże doświadczenie biznesowe, inwestor projektu, brak wiedzy technicznej

Odpowiedzialności	[List odpowiedzialności (oraz interesów) w stosunku do naszego systemu.] System bezpośrednio przekłada się na pracę kliniki, która jest jego własnością
Czynniki sukcesu	[Jak użytkownik definiuje sukces? W jaki sposób jest wynagradzany?] Zwiększenie satysfakcji klienta oraz pracowników
Zaangażowanie	[Jak bardzo jest zaangażowany w projekt? Określ jego rolę w projekcie.] Zatwierdza główną idee projektu. Finansuje projekt
Produkty	[Czy istnieją jakiekolwiek produkty które tworzy – jeżeli tak to dla kogo?] Nie
Komentarze i problemy	[List odpowiedzialności (oraz interesów) w stosunku do naszego systemu.] System bezpośrednio przekłada się na pracę kliniki, która jest jego własnością

Reprezentant	[Kto reprezentuje tego udziałowca w naszym projekcie? Powinny znaleźć się tutaj nazwiska osób.]
Opis	[Krótki opis typu udziałowca] Kierownik kliniki
Rodzaj	[Określenie doświadczenia, wiedzy technicznej oraz poziomu zaawansowanie udziałowca. Np. guru, biznes, export, zwykły użytkownik ,itp.] Duże doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu projektami, brak wiedzy technicznej
Odpowiedzialności	[List odpowiedzialności (oraz interesów) w stosunku do naszego systemu.] System bezpośrednio przekłada się na pracę kliniki, za którą jest odpowiedzialny
Czynniki sukcesu	[Jak użytkownik definiuje sukces? W jaki sposób jest wynagradzany?] Zwiększenie satysfakcji klienta oraz pracowników
Zaangażowanie	[Jak bardzo jest zaangażowany w projekt? Określ jego rolę w projekcie.] Szuka osób/firmy które wykonają projekt
Produkty	[Czy istnieją jakiekolwiek produkty które tworzy – jeżeli tak to dla kogo?] Nie
Komentarze i problemy	[List odpowiedzialności (oraz interesów) w stosunku do naszego systemu.] System bezpośrednio przekłada się na pracę kliniki, za którą jest odpowiedzialny

1.7.4.3.5 Profile użytkowników

[Opisz każdy unikalny rodzaj użytkownika według poniższej tabeli.]

1.7.4.3.5.1 <Nazwa użytkownika>

Reprezentant	[Kto jest reprezentantem użytkownika w projekcie ? Często odnosi się do udziałowca reprezentującego ten typ uczestnika końcowego.]
Opis	[Opis typu użytkownika.] Klient
Rodzaj	[Określenie doświadczenia, wiedzy technicznej oraz poziomu zaawansowanie

	użytkownika. Np. guru, zwykły użytkownik ,itp.] Zwykły użytkownik
Odpowiedzialności	[List odpowiedzialności (oraz interesów) w stosunku do naszego systemu.] brak
Czynniki sukcesu	[Jak użytkownik definiuje sukces? W jaki sposób jest wynagradzany?] Łatwiejsze ustalanie wizyt
Zaangażowanie	[Jak bardzo jest zaangażowany w projekt? Określ jego rolę w projekcie.] Opiniuje projekt
Produkty	[Czy istnieją jakiekolwiek produkty które tworzy – jeżeli tak to dla kogo?] Nie
Komentarze i problemy	[Problemy które mogą zakłócić sukces projektu i pozostałe komentarze] Brak

Reprezentant	[Kto jest reprezentantem użytkownika w projekcie ? Często odnosi się do udziałowca reprezentującego ten typ uczestnika końcowego.]
Opis	[Opis typu użytkownika.] Lekarz
Rodzaj	[Określenie doświadczenia, wiedzy technicznej oraz poziomu zaawansowanie użytkownika. Np. guru, zwykły użytkownik ,itp.] Zwykły użytkownik
Odpowiedzialności	[List odpowiedzialności (oraz interesów) w stosunku do naszego systemu.] Opiniuje
Czynniki sukcesu	[Jak użytkownik definiuje sukces? W jaki sposób jest wynagradzany?] Łatwość w sprawdzaniu grafika
Zaangażowanie	[Jak bardzo jest zaangażowany w projekt? Określ jego rolę w projekcie.] Przedstawia oczekiwania
Produkty	[Czy istnieją jakiekolwiek produkty które tworzy – jeżeli tak to dla kogo?] Nie
Komentarze i problemy	[Problemy które mogą zakłócić sukces projektu i pozostałe komentarze] Brak

Reprezentant	[Kto jest reprezentantem użytkownika w projekcie ? Często odnosi się do udziałowca reprezentującego ten typ uczestnika końcowego.]
Opis	[Opis typu użytkownika.] Recepcjonista/Recepcjonistka
Rodzaj	[Określenie doświadczenia, wiedzy technicznej oraz poziomu zaawansowanie użytkownika. Np. guru, zwykły użytkownik ,itp.] Główny użytkownik z wiedzą o harmonogramach i zarządzaniu informacją odnośnie wizyt
Odpowiedzialności	

	[List odpowiedzialności (oraz interesów) w stosunku do naszego systemu.] Wspiera tworzenie narzędzia
Czynniki sukcesu	[Jak użytkownik definiuje sukces? W jaki sposób jest wynagradzany?] Odciążenie jego pracy
Zaangażowanie	[Jak bardzo jest zaangażowany w projekt? Określ jego rolę w projekcie.] Opiniuje oraz przedstawia potrzeby
Produkty	[Czy istnieją jakiekolwiek produkty które tworzy – jeżeli tak to dla kogo?] Nie
Komentarze i problemy	[Problemy które mogą zakłócić sukces projektu i pozostałe komentarze]

1.7.4.3.6 Główni uczestnicy lub potrzeby klienta

[Wymień główne problemy w istniejących rozwiązaniach z punktu widzenia udziałowca. Dla każdego problemu udziel odpowiedzi na następujące pytania:

- Jakie są przyczyny problemu?
- Jak jest rozwiązywany w chwili obecnej?
- Jakiego rozwiązania oczekuje klient?]

[Istotne jest zrozumienia względnego priorytetu jaki udziałowiec przydziela każdemu problemowi. Należy zidentyfikować problemy które muszą być rozwiązane oraz te którymi udziałowcy chcieliby żeby się zająć.

Wypełnij poniższą tabele.]

1.7.4.3.7 Alternatywy i konkurencja

[Identyfikacja alternatywnych rozwiązań z punktu widzenia udziałowców. Powinna uwzględniać zakup produktu konkurencji, stworzenie tymczasowego rozwiązania lub utrzymania istniejącej systuacji .Wymień wszystkie konkurencyjne rozwiązania które istnieją lub mogą zaistnieć. Opisz ich głowne wady i zalety z punktu widzenia udziałowca]

1.7.4.4 Ograniczenia

[Wymień wszystkie ograniczenia projektowe, zewnętrzne oraz inne zależności.]

- Największym zagrożeniem jest dobranie grupy specjalistów którzy stworzą odpowiedni system,
- Oraz złe lub niepełne przedstawienie problemów

1.7.4.5 Wymagania jakości

[Zdefiniuj wymagania jakościowe dla wydajności, niezawodności, obciążania, użyteczności i podobnych charakterystyk.]

- System musi pracować nieprzerwanie w dni w których klinika pracuje,
- Wytrzymać obciążenia systemowe recepcji oraz klientów,
- Musi działać płynnie i szybko
- Musi być przejrzysta, spełniać standardy wizualne,

- Musi być intuicyjna dla użytkownika końcowego

1.7.4.6 Priorytety

[Określ priorytety dla celów projektu.]

1.7.4.7 Pozostałe wymagania

[Wymagania sprzętowe i systemowe, wymagania środowiskowe, istniejące standardy.]

1.7.4.7.1 Stosowane standardy

[Lista wszystkich standardów do których należy się dostosować Dotyczy to standardów prawnych (FDA, UCC), komunikacyjnych (TCP/IP, ISDN), systemowych (Windows, UNIX, and so on), jakości (UL, ISO, CMM) itp..]

- Baza pacjentów oraz pracowników na której będzie oparty system musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa ze względu na wrażliwe dane, które będą zawarte w bazie,
- System musi być dostępny dla systemu Windows

1.7.4.7.2 Wymagania systemowe i sprzętowe

[Wymagania sprzętowe I systemowe niezbędne do działania aplikacji. Dotyczy to oprogramowania, platform sieciowych, konfiguracji.]

1.7.4.7.3 Wymagania wydajnościowe

[Lista wszystkich wymagań wydajnościowych. Może zawierać takie elementy jak: szerokość łącza, maksymalna ilość użytkowników, przepustowość, precyzję, czas odpowiedzi itp.]

1.7.4.7.4 Wymagania związane ze środowiskiem pracy

Brak

Analiza lingwistyczna

Package in package 'Dokumenty etapu definicji'

Analiza lingwistyczna
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 10.02.2019

Analiza lingwistyczna

Artifact in package 'Analiza lingwistyczna'

Analiza lingwistyczna
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 15.03.2026

1.2.1.1 Analiza lingwistyczna

1.1 Treść

Właściciel prywatnej kliniki „Klinka Medyczna" zlecił firmie informatycznej realizację projektu pod nazwą „System Rezerwacji Wizyt" (SRW). Podstawowym celem systemu będzie usprawnienie procesu rejestracji pacjentów oraz zarządzania grafikiem pracy lekarzy w klinice.

Klinika Medyczna świadczy usługi konsultacji specjalistycznych dla pacjentów prywatnych. W chwili obecnej proces umawiania wizyt odbywa się telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji kliniki. Recepcjoniści zapisują wizyty w papierowym kalendarzu zawierającym grafik lekarzy oraz dostępne terminy.
Klinika uznała, że potrzebny jest system informatyczny SRW wspierający pracę recepcji, lekarzy oraz poprawiający obsługę pacjentów. System ma umożliwiać prowadzenie elektronicznego grafiku pracy lekarzy, przeglądanie dostępnych terminów wizyt oraz dokonywanie rezerwacji wizyt dla pacjentów. Z systemu korzystać będą pracownicy recepcji, którzy będą mogli zapisywać pacjentów na wizyty, zmieniać terminy wizyt oraz odwoływać wizyty w przypadku rezygnacji pacjenta.

System powinien również umożliwiać lekarzom sprawdzanie ich aktualnego grafiku wizyt oraz dostępności terminów. Dzięki temu lekarz będzie miał szybki dostęp do informacji o zaplanowanych wizytach oraz obciążeniu swojego harmonogramu pracy.

Wprowadzenie systemu SRW powinno również usprawnić organizację pracy w klinice. Informacje o wizytach będą dostępne w jednym centralnym systemie informatycznym, co ograniczy liczbę błędów oraz ułatwi kontrolę nad dostępnością terminów. Dodatkowo system umożliwi generowanie prostych raportów dotyczących liczby wizyt, liczby odwołań wizyt oraz obciążenia poszczególnych lekarzy.

1.2 Analiza grup czasownikowych

Grupy czasownikowe	Usługa (przypadek użycia)	Operacja lub odpowiedzialność
zlecił		Zlecanie
realizację		Realizacja
usprawnienie		usprawnienie
zarządzania grafikiem pracy	Zarządzania grafikiem pracy	
świadczy		Świadczenie
zapisują		Zapisywanie
uznała		
wspierający pracę recepcji,	wspieranie pracy recepcji	
poprawiający obsługę pacjentów	poprawienie obsługi pacjentów	
prowadzenie	Prowadzenie grafiku pracy	
dokonywanie rezerwacji wizyt	rezerwacja wizyty	
umożliwi generowanie prostych raportów	generowanie raportów	
odwołań wizyt	odwoływanie wizyt	

1.2 Analiza grup rzeczownikowych

Grupy rzeczownikowe	Kandydat na obiekt	Kandydat na atrybut
właściciel	właściciel	
Klinika Medyczna	klinika	
firma informatyczna	firma informatyczna	
System Rezerwacji Wizyt (SRW)	System Rezerwacji Wizyt	SRW
pacjentów	pacjent	
lekarzy	lekarz	
klinice		
konsultacji specjalistycznych	konsultacja specjalistyczna	
recepcji kliniki	recepcja	
recepcjoniści	recepcjonista	
papierowym kalendarzu	papierowy kalendarz	
grafik lekarzy	grafik pracy lekarzy	
dostępne terminy	grafik wizyt	
klinika		
system informatyczny SRW		
system		
elektronicznego grafiku pracy lekarzy		
dostępnych terminów wizyt		
wizyt	wizyta	
terminy wizyt		
wizyty		
rezygnacji pacjenta	rezygnacja z wizyty	
lekarzom		
grafiku wizyt		
dostępności terminów		
wizytach		
harmonogramu pracy		
systemu SRW		
systemie informatycznym		
raportów	report	
wizyt		
lekarzy		

2. Słownik systemu

** Pacjent jest klientem kliniki, który jest jednoznacznie charakteryzowany przez swój numer PESEL
Pacjent = @PESEL + imię + nazwisko + data urodzenia + płeć + {wizyty}

Płeć = [kobieta | mężczyzna]

** Lekarz jest pracownikiem kliniki, który udziela usług medycznych pacjentom. Jest jednoznacznie identyfikowany przez numer pracownika
Lekarz = @Numer pracownika + imię + nazwisko + {specjalizacja} + numer gabinetu + płaca + grafik

** Recepcjonista jest pracownikiem kliniki, który odpowiada za część logistyczną pracy kliniki. Jest jednoznacznie identyfikowany przez numer pracownika
Recepcjonista = @Numer pracownika + imię + nazwisko + płaca + grafik

** Grafik określa harmonogram pracy pracownika kliniki
Grafik = numer pracownika + data + godzina rozpoczęcia + godzina zakończenia + typ wpisu

Typ wpisu = [praca | urlop płatny | urlop bezpłatny | zwolnienie lekarskie]

** Wizyta jest pojedyńczą jednostką świadczenia usług medycznych pacjentom przez lekarzy

Wizyta = @numer wizyty + rodzaj usługi + data + czas trwania + pacjent + lekarz + status wizyty + cena

Status wizyty = [zaplanowana | zrealizowana | odwołana | nieodbyta]

Raport konfiguracji oprogramowania

Package in package 'Dokumenty etapu definicji'

Raport konfiguracji oprogramowania
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 10.02.2019

Raport konfiguracji oprogramowania

Artifact in package 'Raport konfiguracji oprogramowania'

Raport konfiguracji oprogramowania
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
andrzej.stasiak created on 10.02.2019. Last modified 10.02.2019

1.2.1.2 Raport konfiguracji oprogramowania

...